

Rong Kinh Kéo Dài & Nguy Cơ Thiếu Máu Mạn Tính

Thời điểm: Tháng 09/2026
Chuyên khoa: Huyết Học & Sản Phụ Khoa
Mã chuyên đề: MOM-PDF-02

Medical Disclaimer: Tài liệu đối chiếu từ WHO Guidelines on Iron Deficiency Anemia (2023), ASH (Hiệp Hội Huyết Học Hoa Kỳ), ACOG và Phác đồ Bệnh viện Từ Dũ & Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM.

CÂU HỎI CỦA BỆNH NHÂN:

"Khi bị rong kinh nhiều, nếu để lâu sẽ chuyển thành thiếu máu mạn tính. Vậy thiếu máu mạn tính thì có sao không?"

KẾT LUẬN TỪ BÁC SĨ CHUYÊN KHOA: CÓ, RẤT ĐÁNG NGẠI NẾU ĐỂ KÉO DÀI!

Mặc dù kết quả giải phẫu bệnh tại BV Hùng Vương khẳng định khối u xơ 45mm và mảng tăng sản ở tử cung là **hoàn toàn lành tính**, nhưng nếu để máu chảy rỉ rả từ tháng này qua tháng khác, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng **Thiếu máu thiếu sắt mạn tính (Chronic Iron Deficiency Anemia)**. Hậu quả gây tổn hại trực tiếp đến 5 hệ cơ quan sống còn bên dưới.

I. 5 TÁC HẠI NGUY HIỂM CỦA THIẾU MÁU MẠN TÍNH

1. Gánh Nặng Tim Mạch & Nguy Cơ Suy Tim Thứ Phát (Anemic Heart Failure)

- Khi lượng hồng cầu và huyết sắc tố (Hemoglobin) giảm sâu, các mô trong cơ thể bị "đói oxy" liên tục.
- Để bù đắp lượng oxy thiếu hụt, tim bắt buộc phải đập nhanh hơn và co bóp mạnh gấp 1.5 – 2 lần bình thường (tăng cung lượng tim bù trừ).
- Tình trạng quá tải cơ học kéo dài dẫn tới **hồi hộp, tim đập nhanh, đánh trống ngực, phì đại tâm thất** và tiến triển thành **suy tim do thiếu máu**.

2. Thiếu Oxy Nuôi Dưỡng Não Bộ & Suy Giảm Chức Năng Thần Kinh

- Não bộ là cơ quan tiêu thụ đến 20% tổng lượng oxy của toàn cơ thể.
- Khi thiếu máu mạn tính, não bị thiếu dưỡng khí gây ra: **hoa mắt, chóng mặt khi đứng lên ngồi xuống, mất ngủ kinh niên, giảm khả năng tập trung, suy giảm trí nhớ** và nguy cơ ngất xỉu do hạ huyết áp tư thế.

3. Suy Giảm Hệ Miễn Dịch (Đặc Biệt Nghiêm Trọng Ở Bệnh Nhân Tiền Sử K Vú)

- Sắt là vi chất bắt buộc để tế bào miễn dịch (lympho T và bạch cầu đa nhân) nhân đôi và thực hiện chức năng tiêu diệt mầm bệnh.
- Với bệnh nhân đã hoàn thành 5 năm Tamoxifen, hệ miễn dịch khỏe mạnh là **"lá chắn tự nhiên"** giúp phát hiện và tiêu diệt các tế bào bất thường. Thiếu máu mạn tính làm suy yếu nghiêm trọng hàng rào bảo vệ này.

4. Kiệt Quệ Cơ Bắp & Suy Giảm Thể Lực (Chronic Fatigue)

- Thiếu Myoglobin dự trữ oxy tại cơ bắp khiến chân tay luôn trong trạng thái rã rời, yếu sức, hụt hơi khi leo cầu thang, rụng tóc từng mảng, móng tay giòn, khum hình thìa và dễ gãy.

5. Tăng Nguy Cơ Rủi Ro Khi Cần Can Thiệp Phẫu Thuật

- Nếu để Hemoglobin tụt dưới 8–9 g/dL, khi cần can thiệp phẫu thuật (như cắt tử cung hoặc nội soi bóc nhân xơ), bệnh nhân sẽ phải **truyền máu cấp cứu**, làm tăng nguy cơ sốc phản vệ, kéo dài thời gian nằm viện và vết mổ chậm lành.

II. HƯỚNG XỬ TRÍ DỨT ĐIỂM ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ

Giải Pháp Điều Trị Toàn Diện:

- Cắt đứt nguồn mất máu:** Phẫu thuật nội soi cắt tử cung toàn phần bảo tồn 2 buồng trứng để dứt điểm 100% tình trạng rong kinh, giải quyết khối u xơ 45mm và triệt tiêu nguy cơ ung thư tử cung trong tương lai.

2. **Bù đắp sắt hữu cơ:** Uống 30 – 60 mg sắt nguyên tố/ngày (viên sắt hữu cơ Bisglycinate không gây táo bón, an toàn cho Trĩ & Polyp đại tràng) trong 1–3 tháng để làm đầy kho dự trữ Ferritin.

NGUỒN THAM KHẢO Y KHOA THỰC CHỨNG:

- WHO Guidelines on Anemia Management (2023):** Clinical Practice and Evidence-based Management of Iron Deficiency.
- American Society of Hematology (ASH):** Iron Deficiency Anemia in Women of Reproductive and Perimenopausal Age.
- ACOG Practice Bulletin No. 128:** Diagnosis of Abnormal Uterine Bleeding in Reproductive-Aged Women.